

Doença Inflamatória Intestinal

Avaliação Inicial, Exames e Complicações — **Parte 1**

APOSTILA 1 · PÁGINAS 1-20





Por Que a Avaliação Inicial É Essencial?

Confirmar

Diagnóstico correto antes de qualquer conduta

Classificar

Tipo, extensão e gravidade da doença

Orientar

Tratamento adequado e personalizado

Confirmação Diagnóstica

Antes de qualquer conduta, revisar o diagnóstico e **diferenciar com precisão:**

Doença de Crohn

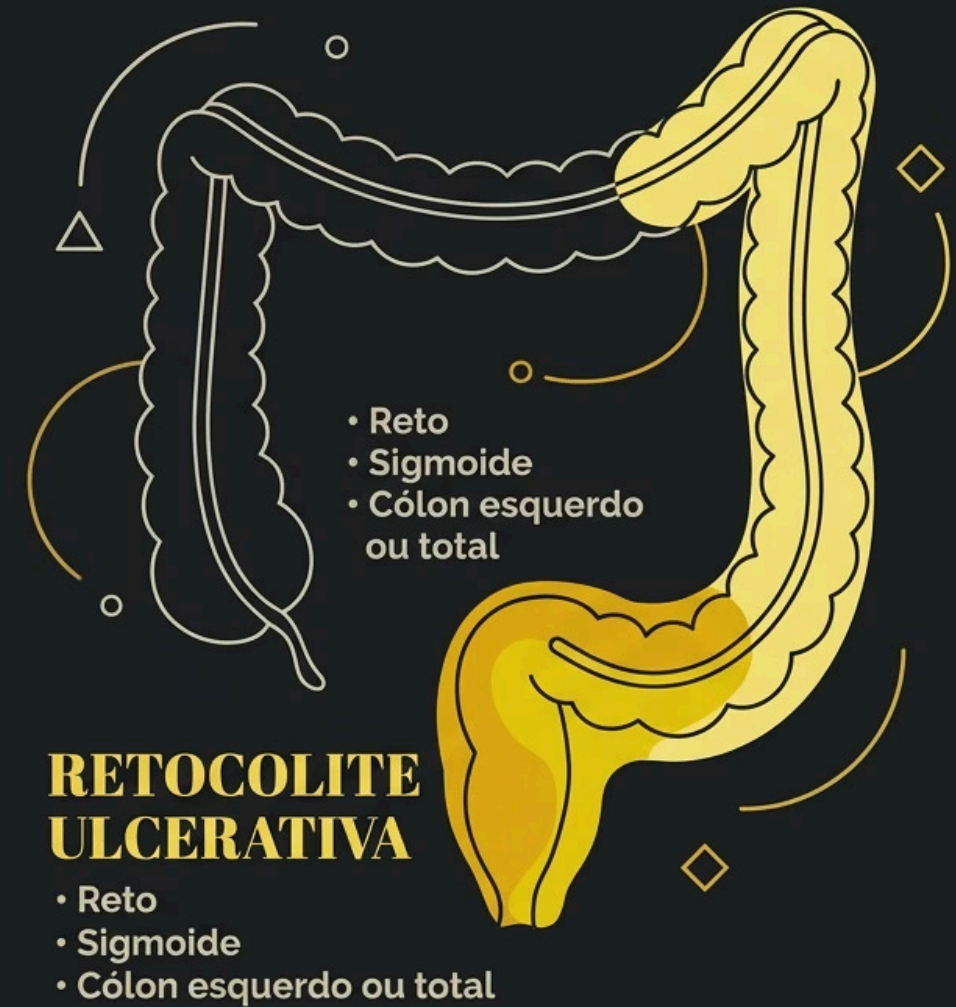
Inflamação transmural, pode acometer qualquer segmento do trato gastrointestinal

Retocolite Ulcerativa

Inflamação mucosa, restrita ao cólon e reto, com padrão contínuo

Localização da Doença

A localização influencia diretamente o manejo terapêutico.



Comportamento da Doença de Crohn

❏ O comportamento muda **completamente** a estratégia de tratamento



Inflamatória

Forma mais comum — responde bem ao tratamento clínico



Estenosante

Formação de estenoses — risco de obstrução intestinal



Fistulizante

Formação de fístulas — manejo cirúrgico frequente

Manifestações Extraintestinais

A DII vai **além do intestino** — afeta múltiplos órgãos e sistemas.



Pele



Olhos



Articulações



Fígado



Sistema Urinário

Fatores de Gravidade

Determinantes para o **prognóstico** e tomada de decisão terapêutica.

Dependência de Corticoide

Incapacidade de reduzir dose sem recaída — indica necessidade de terapia otimizadora

Cirurgias Prévias

Histórico cirúrgico aumenta risco de complicações e recidivas

Medicações Sintomáticas Frequentes

Uso recorrente sugere doença mal controlada ou refratária

Revisão do Histórico Medicamentos

O



1 Adesão

O paciente realmente usa como prescrito?

2 Tempo e Resposta

Quanto tempo em uso? Houve melhora clínica?

3 Efeitos Adversos

Eventos adversos que limitam o tratamento?



Impacto na Qualidade de Vida



Rotina Diária

Sintomas limitam atividades básicas



Trabalho

Absenteísmo e perda de produtividade



Vida Social

Isolamento e impacto emocional significativo

Avaliação Laboratorial Inicial

Exames fundamentais para baseline diagnóstico e acompanhamento.



Hemograma

Anemia, leucocitose, plaquetose



Eletrólitos

Sódio, potássio, magnésio



Função Renal e Hepática

Creatinina, TGO, TGP, albumina



Marcadores Inflamatórios

PCR, VHS — refletem atividade da doença



Perfil de Ferro

Ferritina, ferro sérico, saturação de transferrina

Exames Complementares

Endoscopia

Avalia mucosa, permite biópsia e activity assessment

Ileoscopia

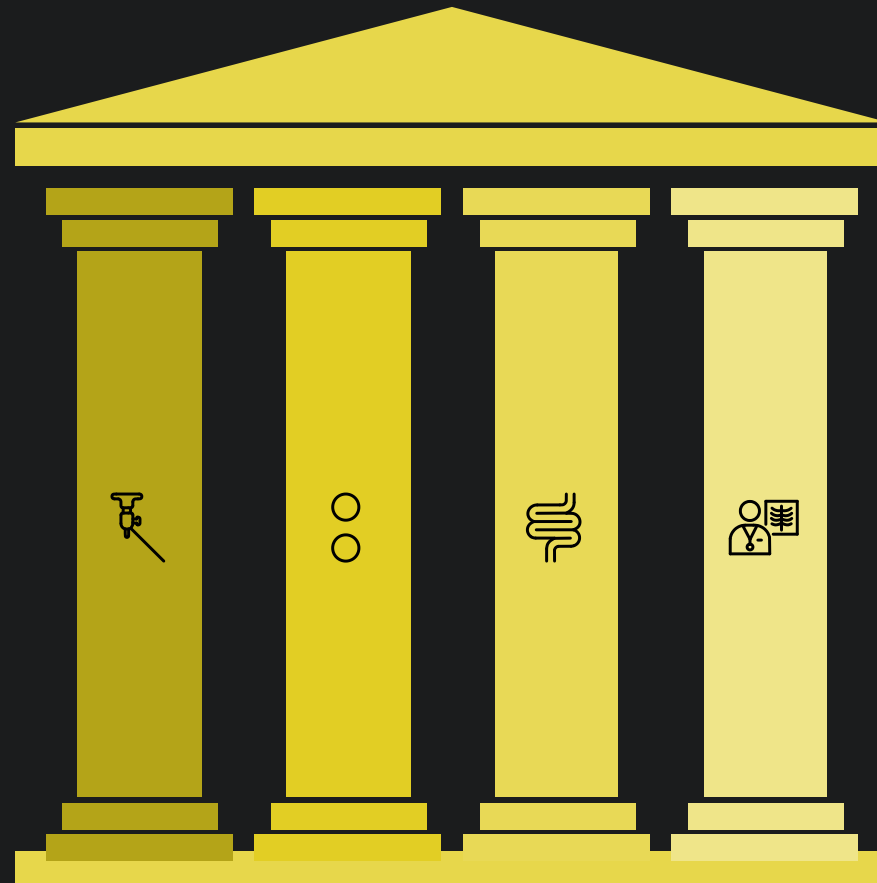
Avalia íleo terminal e dirige coleta de biópsia

Colonoscopia

Visualiza cólon, identifica lesões e inflamação

Métodos de Imagem

Enterorressonância e TC avaliam extensão e fistulas



A combinação de endoscopia e imagem define extensão, atividade e possíveis complicações estruturais.

Rastreamento e Prevenção

Parte essencial do acompanhamento a longo prazo.

Câncer Colorretal

Colonoscopia de vigilância em pacientes com DII de longa data — risco aumentado após 8–10 anos

Atualização Vacinal

Imunossupressão exige calendário vacinal rigoroso — pneumococo, influenza, hepatite B



Diagnóstico Multidimensional

A DII **nunca é diagnosticada por um único exame** — requer integração de múltiplas fontes.



Parâmetros Laboratoriais Chave

PCR ↑

Inflamação Ativa

Elevação proporcional à atividade
inflamatória

Hb ↓

Anemia

Marcador de doença ativa e deficiência
nutricional

Alb ↓

Gravidade

Hipoalbuminemia indica estado
nutricional comprometido

Deficiências Nutricionais na DII

Comuns devido à má absorção e inflamação crônica.



Ferro

Anemia ferropriva — reposição oral ou IV

Vitamina B12

Deficiência no íleo terminal (Crohn)

Ácido Fólico

Risco aumentado com uso de sulfassalazina

Marcadores Sorológicos

Auxiliam na **diferenciação** entre Crohn e Retocolite — uso limitado de forma isolada.

ANCA

Anticorpo anticitoplasma de neutrófilo

Mais comum na Retocolite Ulcerativa

ASCA

Anticorpo anti-Saccharomyces cerevisiae

Mais comum na Doença de Crohn

- ❏ Baixa sensibilidade isolada — melhor quando **combinados** com clínica e endoscopia. Não servem como rastreio populacional.



Marcadores Fecais

Avaliam inflamação intestinal **diretamente**, de forma não invasiva.

Calprotectina

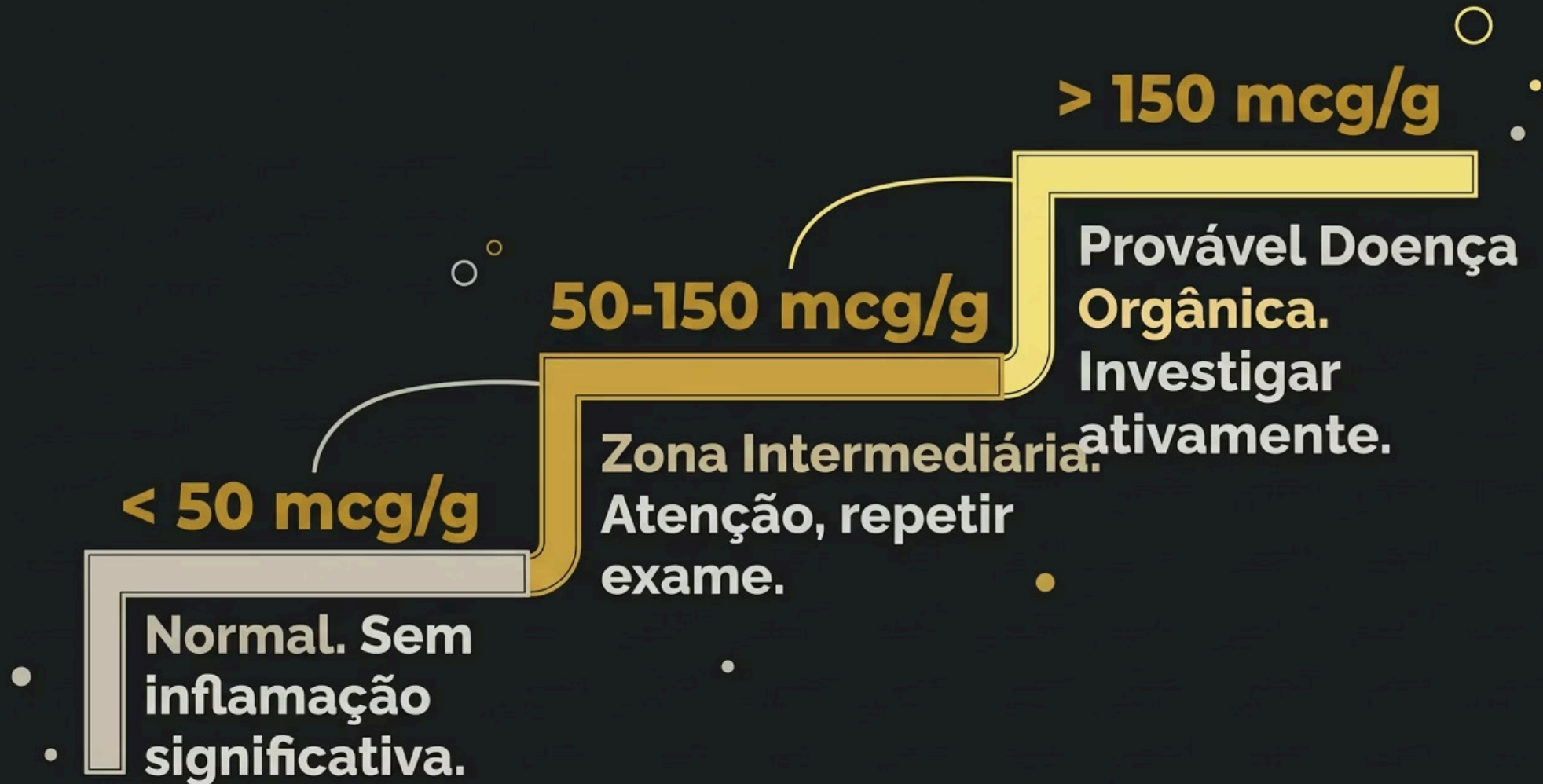
Proteína liberada por neutrófilos — reflete inflamação mucosa com alta sensibilidade

Lactoferrina

Glicoproteína de neutrófilos — correlaciona-se com atividade endoscópica

Calprotectina Fecal

Um dos exames mais úteis para monitorar atividade e resposta ao tratamento.



Interpretação Clínica da Calprotectina

📌 **Atenção:** Elevação da calprotectina NÃO é exclusiva da DII — sempre interpretar no contexto clínico completo.

→ Infecções Intestinais

Gastroenterites bacterianas ou parasitárias elevam calprotectina

→ Doença Celíaca

Inflamação mucosa também eleva os valores

→ Uso de Medicamentos

AINEs podem causar elevação mesmo sem DII ativa

→ Neoplasias

Tumores colorretais podem elevar calprotectina — atenção ao diagnóstico diferencial



Pontos-Chave da Apostila 1

01

Confirmar e Diferenciar

Crohn vs. Retocolite — localização e comportamento definem o tratamento

02

Avaliar Gravidade

Histórico medicamentoso, corticodependência e cirurgias prévias

03

Exames Integrados

Laboratório + endoscopia + imagem + marcadores fecais

04

Contexto Clínico Sempre

Nenhum exame isolado é suficiente — integrar todas as informações